

Diagnóstico de embarazo

1. Introducción y relevancia clínica

El diagnóstico precoz y certero del embarazo es crucial porque permite:

- Iniciar tempranamente el **control prenatal integral**.
- Detectar **embarazos ectópicos o patológicos**.
- Fechar con precisión la gestación, lo que impacta directamente en:
 - La interpretación de ecografías posteriores.
 - El diagnóstico de **restricción de crecimiento intrauterino (RCIU)** o **embarazo prolongado**.
 - La **indicación de interrupción** por causas médicas o legales.

En Chile, según la **Guía Perinatal del MINSAL (2023)**, se considera ideal que la gestante tenga su **primera consulta antes de las 14 semanas**, donde se debe **confirmar el diagnóstico, fechar el embarazo** y solicitar los **exámenes basales del control prenatal**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El embarazo comienza con la **implantación del blastocisto en el endometrio**, alrededor del **día 6–7 post fecundación**. Desde ese momento, el trofoblasto (especialmente el sincitiotrofoblasto) empieza a secretar **gonadotropina coriónica humana (hCG)**, hormona clave para el diagnóstico bioquímico.

a. Función de la hCG

- Estimula al **cuerpo lúteo** para mantener la secreción de **progesterona**, esencial para la supervivencia del embrión hasta que la placenta asuma esa función (≈ semana 10).
- La hCG es detectada en **sangre y orina materna** desde muy temprano:
 - **Sangre:** desde 8–10 días post ovulación.

- **Orina:** 12–14 días post ovulación ($\approx$ día esperado de menstruación).

b. Evolución fisiológica

- Se **duplica cada 48–72 horas** durante las primeras 8–10 semanas.
- Alcanza un **pico entre las semanas 8–10**, luego desciende y se mantiene estable.

Esta curva de crecimiento es fundamental para distinguir un **embarazo normal** de uno **anómalo o ectópico**.

3. Clínica: signos y síntomas de embarazo

El diagnóstico de embarazo se basa en **signos clínicos, pruebas hormonales y ecografía**.

Clásicamente, los signos clínicos se agrupan según su especificidad.

a.

Signos presuntivos (subjetivos)

No son exclusivos del embarazo:

- Amenorrea.
- Náuseas, vómitos, hypersalivación.
- Polaquiuria.
- Fatiga, somnolencia.
- Congestión mamaria o hypersensibilidad.
- Percepción subjetiva de movimientos fetales (después de semana 18).

b.

Signos probables (objetivos pero no diagnósticos)

- Útero globuloso y aumentado de tamaño.

- Reblandecimiento del cuello uterino (**signo de Goodell**).
- Reblandecimiento istmico (**signo de Hegar**).
- Congestión y coloración violácea vaginal (**signo de Chadwick**).
- Positividad de test de embarazo (hCG).

c.

Signos de certeza

- Auscultación de **latidos cardiacos fetales** (desde semana 10–12 con Doppler).
 - **Visualización ecográfica** de saco gestacional intrauterino o embrión.
 - Palpación de partes fetales o movimientos activos (desde 20 semanas).
-

4. Diagnóstico bioquímico

a.

Pruebas de embarazo cualitativas (orina o suero)

- Detectan la **presencia de hCG**.
- Sensibilidad: ≈ 25 UI/L (detecta embarazo desde 10–14 días post ovulación).
- Las pruebas de orina domiciliarias son confiables si se realizan con la **primera orina de la mañana** y al menos **una semana después del retraso menstrual**.

Falsos negativos:

- Test realizado muy precozmente.
- Orina diluida.
- Aborto muy reciente (hCG en descenso).

Falsos positivos:

- Restos de hCG tras aborto o parto reciente.
 - Tumores trofoblásticos (mola hidatidiforme, coriocarcinoma).
 - Producción ectópica (neoplasias germinales).
-

b.

Pruebas cuantitativas (hCG sérica)

Permiten determinar el **nivel exacto** y su evolución en el tiempo.

Son indispensables para:

- Diagnóstico diferencial entre **embarazo normal, ectópico o aborto incompleto**.
- Evaluar **viabilidad embrionaria temprana**.

Valores orientativos:

Edad gestacional	hCG (mUI/ml, rango amplio)
3 semanas	5–50
4 semanas	50–500
5 semanas	500–5.000
6 semanas	1.000–100.000
8–10 semanas	10.000–200.000

☐ En un embarazo viable, la hCG **se duplica cada 48–72 horas**.

Una elevación más lenta o una meseta sugieren **embarazo ectópico o aborto retenido**.

5. Diagnóstico ecográfico

La ecografía es la herramienta más **precisa** para confirmar y datar el embarazo.

a.

Ecografía transvaginal (preferida en 1er trimestre)

- Detecta el **saco gestacional** desde las **4,5–5 semanas**.
- El **embrión con actividad cardíaca** es visible desde las **5,5–6 semanas**.
- Permite confirmar **localización intrauterina, viabilidad y número de embriones**.

b.

Ecografía transabdominal

- Requiere mayor edad gestacional y vejiga llena.
- Detecta saco gestacional a partir de las 6–7 semanas.

c.

Correlación hCG - hallazgo ecográfico (discriminatory zone)

Método	Nivel mínimo de hCG (mUI/ml) para visualizar saco intrauterino
Ecografía transvaginal	1.500–2.000
Ecografía transabdominal	6.000–6.500

Si la hCG está por sobre 2.000 mUI/ml y **no hay saco intrauterino visible**, debe sospecharse **embarazo ectópico**.

d.

Datación ecográfica del embarazo

La **longitud céfalo-caudal (LCC o CRL)** en el **primer trimestre (6–13+6 semanas)** es el método más exacto para calcular la **edad gestacional** (error $\pm 3-5$ días).

Después del primer trimestre, se utilizan:

- **DBP (diámetro biparietal)**
- **CC (circunferencia cefálica)**
- **LF (longitud femoral)**
- **CA (circunferencia abdominal)**

Si la fecha de última regla (FUR) **no coincide con la datación ecográfica en más de 7 días (en T1)**, se debe **reajustar la edad gestacional** a la ecografía.

☐ En Chile, según la Guía Perinatal, la **eco de primer trimestre** es obligatoria y se considera el **estándar de oro** para fechar la gestación .

6. Diagnóstico diferencial

Condición	Características diferenciales
Aborto bioquímico	hCG positiva que luego desciende sin visualizar saco gestacional.
Embarazo ectópico	hCG sube lentamente; no hay saco intrauterino.
Mola hidatidiforme	hCG muy elevada (>100.000); útero grande; imagen ecográfica en “tormenta de nieve”.
Pseudoembarazo	Amenorrea + síntomas, pero test negativo.

7. Conducta y manejo inicial (según Guía Perinatal MINSAL)

Una vez confirmado el embarazo, se debe:

1. **Iniciar control prenatal precoz** (antes de semana 14).
 2. Solicitar exámenes basales:
 - Hemograma, grupo/Rh, orina/urocultivo, VDRL, VIH, HBsAg, TSH si sospecha clínica.
 - Glicemia de ayuno inicial (para tamizaje de diabetes preexistente).
 3. Entregar **educación y suplementos**:
 - **Ácido fólico 1 mg/día** hasta semana 12.
 - Desde semana 16–18, **hierro profiláctico** (30 mg de hierro elemental/día) .
 4. Establecer **edad gestacional definitiva**.
 5. Identificar **factores de riesgo obstétrico** y planificar controles.
-

8. Complicaciones y pronóstico

Error o complicación	Consecuencia
Fechado inadecuado (por FUR incierta)	Mal diagnóstico de RCIU o embarazo prolongado.
Interpretación errónea de test	Falsos negativos en diagnóstico precoz.
No sospechar embarazo ectópico	Riesgo vital materno.
Retraso en control prenatal	Falta de tamizajes y suplementación oportuna.

El pronóstico del embarazo normal confirmado precozmente es **excelente**, especialmente si se inicia control y suplementación antes de las 12–14 semanas.

9. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **hCG se duplica cada 48–72 horas** hasta semana 10; luego disminuye.
2. **Saco gestacional visible por eco TV con hCG >1.500 mUI/ml.**
3. **Eco TV de primer trimestre (6–13+6 s)** es el **método más preciso para datar.**
4. **FUR confiable ± 7 días:** no se corrige; si mayor diferencia, se ajusta.
5. **Amenorrea + test positivo = embarazo** hasta demostrar lo contrario.
6. **No suspender lactancia** por prueba positiva: la hCG no afecta la leche.
7. **hCG muy elevada (>100.000)** con útero grande → sospechar **mola hidatidiforme.**



Errores comunes

- Diagnosticar embarazo sólo con test positivo sin confirmar ecográficamente (riesgo de ectópico).
- Usar creatinina “normal” de adulto para descartar embarazo.
- No corregir la edad gestacional con la primera eco.
- Asumir que todas las amenorreas son embarazos (hipotiroidismo, estrés, etc.).
- No pedir eco ante hCG elevada sin saco visible.

10. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **diagnóstico de embarazo** se confirma con **amenorrea + hCG positiva + ecografía compatible**.
2. La **hCG sérica** se duplica cada 48–72 h hasta la semana 10.
3. El **saco gestacional** es visible por eco transvaginal con hCG >1.500 mUI/ml.
4. La **eco del primer trimestre (6–13+6 s)** es el **método más preciso** para fechar el embarazo.
5. Si **FUR y eco difieren >7 días**, se **corrige según eco**.
6. Una **hCG elevada sin saco intrauterino visible** sugiere **embarazo ectópico**.
7. Confirmado el embarazo, iniciar **control prenatal antes de semana 14**.